

Climatério e menopausa · TH e riscos

Menopausa = 12 meses sem menstruação. Trate sintomas vasomotores e síndrome geniturinária conforme risco CV/câncer — TH não é 'para todas'.

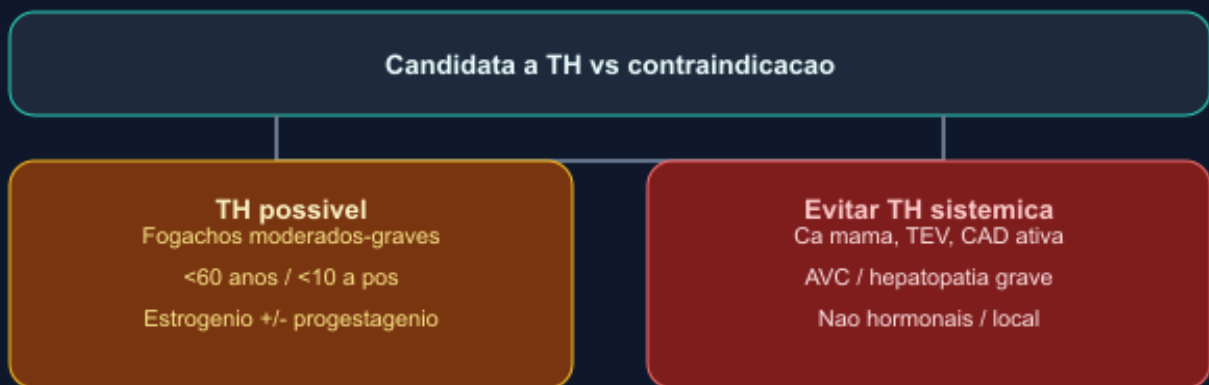
Útero presente

Dica - Útero presente

Estrogênio sistêmico sempre com progestagênio (proteger endométrio). Sem útero: estrogênio isolado.

Janela de oportunidade e ausência de CI definem TH sistêmica; local trata GSM sem os mesmos riscos.

Sintomas da menopausa



Conduta prática

- Não hormonais: ISRS/IRSN, gabapentina, climatério comportamental
- GSM (secura, dispareunia): estrogênio vaginal de baixa dose
- Osso: cálcio/vit D, exercício; densitometria conforme risco; TH ajuda se indicada para sintomas
- Sangramento pós-menopausa: investigar endométrio — nunca 'é só TH'

Contraindicações clássicas à TH

CI | Exemplo

Neoplasia | Câncer de mama hormônio-dependente

Trombose | TEV prévio / trombofilia de alto risco

CV | DAC ativa, AVC recente

Hepática | Doença hepática grave

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não inicie TH só para prevenção primária de CVD ou demência. Sangramento na pós-menopausa = biópsia/avaliação endometrial até prova em contrário.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Climatério/menopausa: STRAW marca estágios; sintomas vasomotores e indicação de TH são o núcleo de prova.

Linha do tempo simplificada STRAW (+10" 2 em torno da FUP).



Sintomas clássicos

- Fogachos / suores noturnos (vasomotores)
- Distúrbios do sono, humor, concentração
- Síndrome geniturinária da menopausa (secura, dispareunia, ITU de repetição)
- Menopausa: 12 meses sem menstruação (FUP = última menstruação)

TH — indicação ideia

Cenário | Ideia

Fogachos moderados/graves, sem contraindicação | TH sistêmica (menor dose efetiva, janela precoce)

Só sintomas geniturinários | Estrogênio local / tópico

Útero presente | Estrogênio + progestagênio (proteger endométrio)

Histerectomizada | Estrogênio só (em geral)

Contraindicações | Câncer mama, TEV ativo/alto risco, sangramento vaginal não esclarecido, hepatopatia grave

Janela

Atencao - Janela

Melhor relação risco-benefício da TH sistêmica: início próximo da menopausa (<60 anos ou <10 anos da FUP), individualizando riscos.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1